

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE IMPACTO DEL EVENTO REVISADA (IES-R)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación de Estrés Postraumático (Intrusión, Evitación e Hiperactivación)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Impacto del Evento Revisada (IES-R / EIE-R).
Nombre Original (Inglés)	<i>Impact of Event Scale - Revised (IES-R)</i>
Autores Originales	Daniel S. Weiss y Charles R. Marmar (1997), sobre el modelo original de Mardi Horowitz et al. (1979).
Adaptaciones Españolas	Báguena et al. (2001, validación española de referencia); Caamaño et al. (2011, Chile); Gargurevich et al. (2009).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Evaluación sindrómica reactiva a sucesos traumáticos agudos o crónicos.
Tipo de Instrumento	Escala de autoinforme de 22 reactivos de 5 anclajes (0 = Nada a 4 = Extremadamente).
Población y Rango	Adultos y adolescentes (>= 15 años). Supervivientes de accidentes, catástrofes, agresiones o duelo traumático.
Tiempo de Administración	6 a 10 minutos.
Régimen de Licencia	Dominio público para uso clínico, humanitario y de investigación no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO DEL ESTRÉS TRAUMÁTICO

La IES-R fue desarrollada por Weiss y Marmar (1997) para superar las limitaciones de la escala clásica IES de Horowitz (1979), la cual sólo evaluaba intrusión y evitación. La versión revisada incorporó formalmente la dimensión biológica de la **hiperactivación neurovegetativa** (*hyperarousal*), alineando el instrumento con los criterios nosológicos del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) del DSM-IV y DSM-5.

El instrumento evalúa el grado de sufrimiento subjetivo experimentado durante los **últimos siete días** en relación directa con un **suceso traumático índice específico y delimitado** (accidente grave, agresión sexual, catástrofe natural, pérdida repentina, diagnóstico oncológico). La IES-R captura la alternancia dinámica entre estados de inundación emocional (pesadillas, flashbacks, reactividad fisiológica) y maniobras defensivas de adormecimiento psíquico y distanciamiento cognitivo.

3. SUBESCALAS CLÍNICAS DE LA IES-R (WEISS & MARMAR, 1997)

Subescala Clínica	Ítems	Rango Dir.	Contenido Fenomenológico y Semiológico
1. Intrusión	1, 2, 3, 6, 9, 14, 16, 20	0 a 32	Recuerdos involuntarios vívidos, pesadillas recurrentes, reviviscencias (flashbacks) y reactividad emocional.
2. Evitación	5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 22	0 a 32	Esfuerzos por no pensar o hablar del suceso, evitación de lugares o recordatorios, y embotamiento afectivo.
3. Hiperactivación	4, 10, 15, 18, 19, 21	0 a 24	Respuestas de sobresalto exageradas, irritabilidad, insomnio, hipervigilancia motora y desatención.
PUNTUACIÓN TOTAL IES-R	1 al 22	0 a 88	Índice multidimensional integral de gravedad del impacto traumático durante la última semana.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Excelente consistencia interna en muestras de habla hispana: alfa de Cronbach de 0.92 para la escala global, 0.88 para Intrusión, 0.85 para Evitación y 0.84 para Hiperactivación (Báguena et al., 2001; Caamaño et al., 2011).
Validez Diagnóstica	Para el punto de corte estándar <i>ge33</i> : sensibilidad diagnóstica del 91% y especificidad del 82% frente a entrevistas clínicas estructuradas (CAPS / SCID) para TEPT.
Validez Concurrente	Elevada correlación con el PCL-5 ($r = 0.84$), la escala de ansiedad estado (STAI-E $r = 0.69$) y medidas de depresión (BDI-II $r = 0.65$).
Estabilidad Temporal	Fiabilidad test-retest $r = 0.79$ a 0.89 en intervalos de dos a cuatro semanas en ausencia de intervención activa.
Sensibilidad al Tratamiento	Demuestra reducción cuantitativa robusta y estadísticamente significativa tras terapias de exposición prolongada y EMDR.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN DE ÍTEMS

Cada afirmación se valora en una escala de 5 puntos en función del malestar durante los **últimos 7 días**:

- **0** = Nada | **1** = Un poco | **2** = Moderadamente | **3** = Bastante | **4** = Extremadamente.
- **Puntuaciones de Subescalas:** Suma directa de los reactivos correspondientes:

Intrusión: 8 ítems (0–32) | Evitación: 8 ítems (0–32) | Hiperactivación: 6 ítems (0–24)

- **Puntuación Total IES-R:** Suma de los 22 ítems directos (Rango global: **0 a 88 puntos**).

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA (CREAMER ET AL., 2003; BÁGUENA ET AL., 2001)

Estrato	Puntuación	Estado Postraumático	Conducta Asistencial Recomendada
Bajo	0 a 23	Impacto traumático leve / Normalidad	Reacción de estrés adaptativa o remisión espontánea. Psicoeducación y seguimiento expectante.
Moderado	24 a 32	Impacto moderado / Zona de riesgo	Sintomatología clínicamente significativa. Riesgo de Trastorno Adaptativo o TEPT incipiente.
Severo	33 a 36	Corte Positivo para TEPT	Punto de corte clínico óptimo. Alta probabilidad de diagnóstico formal de TEPT. Psicoterapia focalizada.
Grave/Extremo	37 a 88	TEPT Crítico e Incapacitante	Gravedad extrema con supresión de la función inmunitaria y disfunción sociolaboral total. Abordaje intensivo.

VALOR DEL CORTE DE 33 PUNTOS: En estudios epidemiológicos y ensayos clínicos internacionales (Creamer et al., 2003), una puntuación total *ge33* representa el mejor equilibrio entre sensibilidad (0.91) y especificidad (0.82) para predecir el diagnóstico formal de TEPT.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y TRABAJO CON EL TRAUMA

EVALUACIÓN DE PERFILES DE DESCOMPENSACIÓN:

- **Predominio de Intrusión e Hiperactivación:** El paciente vive en estado de alarma fisiológica continua; requiere de forma prioritaria estabilización con técnicas de conexión a tierra (*grounding*) y desactivación autonómica antes de abordar el recuerdo.
- **Predominio de Evitación Severa:** Pacientes con embotamiento afectivo masivo y conductas de aislamiento; alto riesgo de cronicidad. Tratamiento de elección mediante exposición in vivo y desensibilización sistemática (EMDR o terapia cognitivo-conductual centrada en trauma).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN TRAS ACCIDENTE DE TRÁFICO

Paciente: Mujer de 33 años, comercial de ventas, que sufrió un accidente de tráfico grave por alcance en autopista hace 6 semanas. Consulta por imposibilidad absoluta para volver a conducir, taquicardia al subirse como copiloto e insomnio por pesadillas recurrentes del impacto.

Puntuación IES-R Total: 49/88 (Rango Grave — Positivo para TEPT).

- **Desglose por subescalas:** Intrusión = 21/32 (imágenes continuas del choque y dolor en el pecho al oír frenazos); Hiperactivación = 16/24 (sobresaltos motores extremos y dificultad para concentrarse); Evitación = 12/32 (se niega a desplazarse en coche).

Conducta Asistencial: Se diagnostica Trastorno de Estrés Postraumático (DSM-5). Se aplica protocolo EMDR de 8 sesiones focalizado en la diana del impacto automovilístico, junto con exposición gradual in vivo a la conducción. A las 8 semanas, la puntuación total en la IES-R descendió a 14/88 (rango bajo normal), remitiendo las pesadillas y recuperando la capacidad para conducir de forma autónoma.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA

ALERTA: RIESGO DE DISOCIACIÓN AGUDA

Puntuaciones máximas de intrusión pueden desencadenar despersonalización o fugas disociativas durante la exploración clínica; mantener siempre contacto con el presente mediante anclaje sensorial.

AUTOMEDICACIÓN CON ALCOHOL

La hiperactivación nocturna induce con frecuencia el consumo de alcohol o benzodiacepinas para sedarse; evaluar sistemáticamente el consumo de sustancias para evitar dependencia cruzada.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Weiss, D. S., & Marmar, C. R. (1997). The Impact of Event Scale - Revised. In J. P. Wilson & T. M. Keane (Eds.), *Assessing psychological trauma and PTSD* (pp. 399–411). Guilford Press.
2. Báguena, M. J., Villarroya, E., Beleña, A., Díaz, A., Roldán, C., & Reig, R. (2001). Propiedades psicométricas de la versión española de la Escala de Impacto del Evento-Revisada (EIE-R). *Análisis y Modificación de Conducta*, 27(114), 581–604.
3. Caamaño, L., Fuentes, D., González, L., et al. (2011). Adaptación y validación de la versión chilena de la escala de impacto de evento-r. *Revista Médica de Chile*, 139(9), 1163–1168.
4. Creamer, M., Bell, R., & Failla, S. (2003). Psychometric properties of the Impact of Event Scale-Revised. *Behaviour Research and Therapy*, 41(12), 1489–1496.